第二十二章 恶性肿瘤的全科医学处理

本章数字资源

学习提要

- 掌握肿瘤的定义和分类、恶性肿瘤的临床表现、恶性肿瘤的诊断、恶性肿瘤的三级预防。
- 熟悉恶性肿瘤的危险因素、恶性肿瘤的心理社会干预、恶性肿瘤的综合治疗原则。
- 了解恶性肿瘤的流行病学、基层医疗服务在恶性肿瘤管理中的作用。

肿瘤（tumor/neoplasm）是机体在内、外各种致瘤因子的长期协同作用下，局部组织细胞在基因水平上失去对其生长的正常调控，导致细胞异常增殖而形成的新生物。分为良性肿瘤（benign tumor）、恶性肿瘤（malignant tumor）以及介于良性和恶性之间的交界性肿瘤（borderline tumor）。肿瘤作为一种与生活方式密切相关的慢性疾病，日常的饮食习惯、生活环境、心理特点、行为方式、病菌感染和自身代谢等因素均会影响肿瘤的发生发展。通过改善生活方式和控制心理、行为、环境等因素的影响，40% 的肿瘤是可以预防的。另外，采取“早发现、早诊断、早治疗”的措施，将肿瘤消灭在早期阶段，不仅可以有效地提高患者的生存率，改善生活质量，而且会极大降低肿瘤的治疗费用，减轻家庭和社会的经济负担。

【临床病例】

主观资料（S）：患者，女性，50 岁，因“间断腹痛 2 年，加重 1 周”至社区全科门诊就诊。

现病史：2 年前患者间断出现中下腹痛，常于夜间出现，发作时经禁食、抗感染、解痉、镇痛等治疗后好转。1 年前母亲去世后出现食欲减退，乏力，伴心情郁闷，睡眠差。近 1 周腹痛发作频繁，经上述治疗效果不佳。发病以来，腹痛常伴有恶心、呕吐，无腹泻，无黑便等。

既往史：否认高血压、糖尿病、心脏病、肾病病史，否认肺结核、病毒性肝炎及其他传染病，无食物、药物过敏史，无外伤、手术及输血史，疫苗接种史不详。

个人史：无烟酒等特殊嗜好。无毒物及放射性物质接触史。

婚育史：育有 1 子，体健。

家族史：父亲健在，母亲 1 年前因脑梗死去世，家族成员无类似疾病史。

客观资料（O）：

体格检查：血压 120/80mmHg，神清语利，贫血貌，心肺（－），腹软，脐周及左下腹有压痛，无反跳痛。

【问题 1】通过上述问诊与体格检查，该病例的临床特点有哪些？

思路 1：该病例的临床特点：患者，中年女性，间断腹痛 2 年，腹痛发作时经禁食、抗感染、解痉、镇痛等治疗后好转，近 1 周腹痛发作频繁，治疗效果不佳。1 年前母亲去世后出现食欲减退，乏力，伴心情郁闷，睡眠差。体格检查：脐周及左下腹有压痛，无反跳痛。

知识点

恶性肿瘤的临床表现

一、常见症状

1. 出血　肺癌所致出血常为痰中带血，侵蚀血管造成大出血罕见；上消化道肿瘤的出血常为缓慢、间歇性，可引起缺铁性贫血，呕血或严重的黑便较少见；升结肠肿瘤常出现失血性贫血。

2. 穿孔　原发性或转移性肺癌可引起气胸；胃癌可致胃穿孔；胃癌侵犯横结肠，可形成胃-结肠瘘；食管癌可致气管-食管瘘。

3. 疼痛　多数肿瘤开始时无痛，当侵犯、压迫神经，或因破溃、感染而刺激神经时，可引起疼痛。梗阻近端肠段的蠕动可致绞痛。

4. 梗阻　空腔脏器如消化道恶性肿瘤腔内生长型，到一定阶段可引起梗阻性表现。如消化道恶性肿瘤可引起疼痛、恶心、呕吐、停止排气排便等。呼吸道恶性肿瘤可引起气道梗阻，如呼吸困难、肺不张等。

5. 类癌综合征　某些肿瘤可异位分泌激素，如肾上腺嗜铬细胞瘤可致高血压，肺癌可致库欣综合征。肿瘤亦可引起神经、肌肉、骨骼、皮肤、血液等方面的副肿瘤综合征，如小脑皮质变性、癌性肌病、皮肌炎、杵状指/趾和红细胞增多症等。

二、体征

1. 淋巴转移（淋巴结肿大）　是恶性肿瘤常见的转移方式，特别是晚期肿瘤。有的可成为肿瘤首发表现，如左锁骨上淋巴结肿大可以是晚期胃癌的首发表现，腋窝淋巴结肿大是乳腺癌的首发表现等。

2. 血行转移　在肿瘤晚期并不少见。血行转移的途径主要有：①体循环静脉系统：四肢肉瘤的肺转移；②动脉系统：肺癌的骨转移和脑转移；③门脉系统：胃肠道肿瘤的肝转移；④脊椎静脉系统：前列腺癌的脊椎转移。

3. 种植性转移　胃癌、结直肠癌的腹膜腔和盆腔种植转移；肺癌、乳腺癌的种植性转移可引起胸腔积液。

4. 恶病质　是晚期肿瘤患者全身衰竭的表现，消化道肿瘤出现较早。

思路 2：母亲去世带给患者的长期心情郁闷和痛苦可能是患者疾病进展的重要因素；不能及时从精神创伤中走出来的不良心理状态是患者发生肿瘤的危险因素。

知识点

肿瘤的危险因素

肿瘤是多因素参与和多阶段发展的疾病，其病因及危险因素主要包括两方面：环境致癌危险因素和个体内在因素。各种环境致癌因素可独立或相互协同作用于机体，与内在因素相互作用，通过不同的复杂机制引起细胞遗传学改变并不断积累，最终导致肿瘤的发生。

1. 环境致癌危险因素

（1）化学致癌因素：化学致癌物是指所有能引发癌症的化学物质。主要包括烷化剂类、多环芳烃类、芳香胺类、偶氮染料和亚硝基化合物等。

（2）物理致癌因素：物理致癌因素包括电离辐射、紫外线辐射和某些矿物纤维如石棉。电离辐射的暴露可来自天然或人为因素。人源性辐射暴露多为医源性，包括影像诊断、核医学和肿瘤放射治疗等。

（3）生物致癌因素：生物致癌因素主要是致癌性病毒，也包括一些细菌及寄生虫。如乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）与肝细胞癌，EB 病毒与鼻咽癌和 Burkitt 淋巴瘤，人乳头瘤

病毒与宫颈癌的发生密切相关。幽门螺杆菌（Helicobacter pylori，Hp）感染与非贲门部胃癌的发生密切相关。

（4）生活方式危险因素：多种生活方式与肿瘤的发生相关，包括吸烟、饮酒、不良饮食习惯、精神创伤、肥胖、体力活动不足等。

2. 个体内在因素　虽然大多数肿瘤与环境致癌因素有关，但有同样暴露的一群人，仅有少数人患肿瘤，这种生物效应的差异与个人的遗传因素、心理状态、免疫状态、营养状态等个体内在因素密切相关。

思路 3：患者为中年女性，间断中下腹疼痛 2 年，发作时经禁食、抗感染、解痉、镇痛等治疗后好转。作为全科医师要考虑患者腹痛首先可能是慢性肠道疾病。

思路 4：患者近 1 周腹痛加重，按以往治疗效果不佳，查体阳性体征有：贫血貌，脐周及左下腹有压痛，无反跳痛。结合既往患者有精神创伤史，考虑患者不能完全排除肠道肿瘤性疾病。

【问题 2】患者的初步诊断是什么？是否需要转诊？

思路 1：结直肠癌在 41~65 岁人群发病率高，患者为 50 岁，慢性病程，为结直肠癌好发年龄。

思路 2：患者为中年女性，间断中下腹疼痛 2 年，1 年前有精神创伤史，近 1 周腹痛发作频繁，经禁食、抗感染等治疗效果不佳，查体有贫血貌，初步诊断为肠道肿瘤或炎症性疾病。

思路 3：患者需要进一步进行实验室检查、影像学检查和消化道内镜检查以明确诊断，基层现有条件难以完成，需要及时转诊到上级医院。

知识点

肿瘤的流行病学

随着我国人口老龄化进程加速和疾病谱的变化，恶性肿瘤、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性疾病成为了中国城乡居民的主要疾病死因。2022 年 2 月，国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。2016 年我国癌症发病情况：新发病例 406.4 万；世标发病率 186.46/10 万，男性高于女性（207.03/10 万 vs 168.14/10 万）。年龄差异：在 0~19 岁、60 岁以上，男性高于女性；在 15~59 岁，女性高于男性。男女癌症新发病例峰值均在 60~79 岁。地域差异：发病率总体上城市高于农村（189.7/10 万 vs 176.2/10 万）；肺癌、乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌城市高于农村；胃癌、肝癌、宫颈癌、食管癌农村高于城市。2016 年我国癌症死亡情况：总死亡人数 241.4 万；世标死亡率 105.19/10 万，男性高于女性（138.14/10 万 vs 73.95/10 万）。性别差异：所有年龄段男性死亡人数均高于女性；胆囊癌、甲状腺癌死亡率女性高于男性；其他所有癌种死亡率男性高于女性。年龄差异：0~14 岁、60 岁以上，男性高于女性；15~59 岁，女性高于男性；60~79 岁，死亡率最高。地域差异：死亡率总体上农村高于城市（106.1/10 万 vs 102.8/10 万）；肺癌、结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌城市高于农村；肝癌、胃癌、食管癌、宫颈癌农村高于城市。

在过去的 10 余年里，恶性肿瘤患者生存率呈现逐渐上升趋势。目前，我国恶性肿瘤患者的 5 年相对生存率约为 40.5%，与 10 年前相比，总体提高约 10 个百分点，但是与发达国家还有很大差距。其主要原因是我国肿瘤谱和发达国家肿瘤谱存在差异，在我国，预后较差的消化系统肿瘤如肝癌、胃癌和食管癌等高发，而在欧美发达国家则是甲状腺癌、乳腺癌和前列腺癌等预后较好的肿瘤高发。但必须看到，在我国，预后较好的肿瘤，如乳腺癌（82.0%）、甲状腺癌（84.3%）和前列腺癌（66.4%），患者的 5 年生存率仍与美国等发达国家存在差距（乳腺癌、甲状腺癌和前列腺癌依次为：90.9%、98% 和 99.5%）。出现这种差距的主要原因是临床早期患者就诊率低和临床晚期诊治不规范。

临床病例(续)

初步评估(A):

患者转诊到某三甲医院,辅助检查:血常规:白细胞 4.5×10^9/L,血红蛋白 80g/L,血小板 200×10^9/L。粪便隐血试验:(+)。腹部 CT:左侧结肠肿物。电子肠镜:乙状结肠癌。病理诊断:腺癌。

综合上述资料,患者诊断为结肠癌。

处置计划(P):

患者在肛肠外科行乙状结肠癌根治术,术后病理诊断:溃疡型腺癌。

【问题 3】患者的诊疗思路是什么?

思路 1:患者腹痛伴有贫血,粪便隐血试验(+),肠道炎症、溃疡、息肉、恶性肿瘤均可以出现上述表现,需要通过影像学检查和内镜检查鉴别。

思路 2:专科医师全面评估患者的总体情况,包括年龄、心肺功能、肝肾功能、心理状态、患者与家属对疾病的认知等,经与家属协商后决定:采取手术+化疗。

知识点

恶性肿瘤的诊断与治疗

一、恶性肿瘤的诊断

全面的病史采集和体格检查可以发现恶性肿瘤的早期征象,并且配合必要的辅助检查以进行诊断。影像学检查对于肿瘤诊断和分期是最基本的;病理诊断是最关键的也是必不可少的检查。有时需要借助实验室检查、影像学检查,甚至一些侵入性检查协助诊断。

1. 病史采集　包括年龄、病程、既往慢性病史、家族史或遗传史(如胃癌、结直肠癌、食管癌、乳腺癌等可有家族聚集倾向)、癌前疾病及相关疾病史(如慢性乙肝病毒携带与肝癌相关,慢性萎缩性胃炎、胃息肉是胃癌的癌前疾病)、个人的不良生活方式(如吸烟、嗜酒、久坐不动、空气或饮用水污染)等。

2. 体格检查　包括全身一般情况、精神心理状况和全身浅表淋巴结是否肿大等,详细的局部查体,如肿块部位、大小、性质等。

3. 辅助检查　实验室检查包括常规检查如血、尿、便常规和粪便隐血检查,肿瘤标志物检查,如甲胎蛋白(AFP)>400μg/L 有助于原发性肝癌的诊断;癌胚抗原(CEA)增高,可能与消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌有关;CA-199 增高见于胰腺癌、胃癌等;前列腺特异性抗原(PSA)明显升高见于前列腺癌等。

影像学检查包括超声检查、X 线检查(如胸片、钼靶 X 线摄片)、CT、MRI、正电子发射计算机断层成像(PET-CT)、造影检查如胃肠道钡餐造影等。内镜检查有支气管镜、胃镜、肠镜、膀胱镜等,可直接观察病变部位、形态,并取病变组织进行病理学检查。病理学检查是确诊肿瘤的“金标准”。恶性肿瘤的临床诊断应包括肿瘤的原发部位(定位)、病理诊断(定性)、临床分期(定量)。临床分期通用 TNM 分期,即肿瘤的局部生长(T)、淋巴结转移(N)和远处转移(M)。通过对 T、N、M 的分级,可以精确地描述和记录疾病的解剖学侵及范围。

二、恶性肿瘤的治疗

肿瘤的治疗包括手术治疗、放射治疗、化学治疗、介入治疗、内分泌治疗、分子靶向治疗、免疫治疗、中医药治疗等,均需要由专科医生施行。单一治疗手段局限性较大,需要全方位、多学科的综合治疗。

1. 综合治疗　肿瘤的综合治疗是多学科医疗团队根据患者的具体情况、肿瘤的病理类型、侵犯范围和发展趋向,有计划、合理地应用现有的治疗手段,进行综合治疗,以期提高治愈率。手

术+化疗和/或放疗是应用最为普遍的一种综合治疗方式(如在乳腺癌的治疗方面)。

2. 综合治疗的主要原则　肿瘤局部侵犯超出可切除范围时,如喉癌、食管癌、胰腺癌、子宫颈癌、前列腺癌,放疗常作为首选治疗,有时也可用在化疗或内分泌治疗之后。首诊时不可手术的肿瘤,通过化疗或放疗有可能使其变成可手术的肿瘤。对于姑息和缓解疼痛者,可给予放疗、靶向治疗等。

不论采取哪种治疗方法,均以提高生活质量和延长生命为目标。全科医生应协助专科医生,综合考虑患者的病情,征求患者与家属的意见,遵循个体化原则,采取合适的治疗手段,并要定期进行随访。

临床病例(续)

术后患者出现焦虑、进食差、失眠、夜间烦躁,伴有发热、伤口感染、愈合困难,请精神科和感染科医生会诊,每日给予镇痛、镇静、抗感染、补液等治疗,效果不佳,症状逐渐加重。为进一步综合治疗,术后 3 周后患者转入全科医学科病房。经全科医生多次与患者深入交谈,了解其患病及诊疗的心理过程,给予精神支持、安慰、共情,引导其接纳疾患、乐观面对痛苦,鼓励其运动,配合补液、抗感染、营养等综合治疗,并逐渐减少镇静、镇痛药物。1 周后患者饮食渐趋好转,体温正常、睡眠改善、精神状态转好,随后出院。全科医学科医生通知签约的社区全科医生进行后期随访管理。

【问题 4】医院全科医学科医生与其他专科医生如何进行合作?

思路:患者诊断明确后,决定采取手术+化疗,这需要由外科医生和肿瘤科医生来实施。但是恶性肿瘤诊治对个体患者和家庭都是强烈的心理打击,由于对疾病的恐惧和对前途的忧虑,患者很容易出现紧张、焦虑、失眠、抑郁,甚至自杀等多种心理问题。心理问题如不能有效解决,针对肿瘤的专科治疗将有可能受到严重影响。该患者术后就出现了焦虑、失眠、烦躁等精神心理问题,合并发热、伤口感染、愈合困难等并发症。尽管外科医生已请精神科和感染科医生会诊协助治疗,但是患者术后的综合管理,需要医生具有对多病共存患者和精神心理问题患者综合、持续的管理能力,这是医院全科医学科医生的专业特长。该患者转科到全科医学科病房后,全科医学科医生对患者患病及诊疗经过进行详细了解,给予患者强大的精神支持,安慰、共情,引导其接纳疾患,加上药物等综合治疗,患者很快得到了康复。

知识点

恶性肿瘤患者的心理社会干预

全科医学强调以人为中心的健康照顾。全科医生更应该关注的是患了肿瘤的人,而非这个个体发生的肿瘤。晚期肿瘤患者,由于对疾病的恐惧、对前途的忧虑,出现焦虑、抑郁等心理问题的情况,较其他疾病患者更为普遍。这些心理问题的解决有赖于全科医生的帮助。

恶性肿瘤患者在诊断和治疗过程中,常常出现难以控制的焦虑不安、恐惧、怀疑、自卑、疑病等情绪,还可能会出现抑郁、自杀倾向、谵妄等严重的精神问题。医生要掌握肿瘤患者可能出现的心理问题及疾病。在治疗过程中,注意态度和蔼、亲切,学会倾听、观察,与患者建立良好的医患关系,始终坚持平等、尊重和信任的原则,充分调动和发挥患者的心理能动性,积极引导患者解决各种心理问题。

临床病例(续)

该患者出院回到社区,并将出院小结交给签约全科医生。此后,全科医生开展了以下工作。

针对患者:

1. 了解患者治疗方案、目前所用药物、随访间期。督促其定期去医院外科医生处随访,每年复查1次肠镜。

2. 定期了解患者饮食、身体活动情况、心理精神和睡眠状态。

3. 指导患者建立正确的生活方式,嘱其保持良好心态、营养均衡、大便通畅等。

针对家属:

1. 要求其配偶、子女接受和适应患者的疾病,多关心、照顾患者心理和生活。

2. 告知家属让患者多食用低脂且含有膳食纤维的食物(如蔬菜、大豆等),避免摄入辛辣刺激性食物,补充钙剂及维生素。

3. 告知患者放松心情,保持心情愉悦,健康作息;适当锻炼身体,增强抵抗力。

4. 告知出现可能提示病情加重的情况时,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便血等,应及时复诊;强调定期复查的重要性。

与专科医生沟通:

1. 学习最新结肠癌临床实践指南中术后的推荐意见,与专科医生讨论针对该患者进行临床实践的可行性。

2. 定期汇报该患者心身动态。

3. 患者情况变化时,如呕吐、腹痛,出现肝功异常、黑便等,及时转诊。

【问题5】患者出院后,社区全科医生需要做哪些工作?

思路:该患者手术治疗很成功,但其身体和心理仍需很长时间康复,尤其回到社区后,她的生活较前会发生改变,出院后哪些食物对疾病康复有益?服用的一些胃肠道药物有什么注意事项?再出现腹痛、呕吐、腹泻等症状怎么办?出现哪些情况直接去医院就诊?

知识点

基层全科医疗服务在恶性肿瘤管理中的作用

1. 辅助恶性肿瘤治疗　在恶性肿瘤的治疗过程中,虽然治疗方案的制订和执行主要由肿瘤专科医生完成,但全科医生的作用不可或缺,主要表现在以下方面:①全科医生是肿瘤患者的全程管理者。②定期随访肿瘤患者,了解其需求。③及时发现肿瘤患者与抑郁相关的心理问题,及早给予处理。④为患者提供就医咨询。⑤为患者提供合适的疼痛管理方案。⑥全科医生是患者最直接的交流者和支持者。⑦让患者知晓相关社区资源和服务。

2. 全-专联合共同管理恶性肿瘤治疗的并发症　虽然化疗和放疗由肿瘤专科医生实施,但全科医生必须了解这些治疗方法潜在的不良反应,必要时与肿瘤科医生共同管理,以减少患者的痛苦。化疗和放疗的常见不良反应包括恶心、呕吐、发热和白细胞减少等。

3. 做好恶性肿瘤患者及家庭的生活方式管理　随着恶性肿瘤治疗技术水平的提高,肿瘤患者的存活时间越来越长。对于肿瘤幸存者,不但要预防复发和转移,而且还要做好心理健康、生活方式管理,预防其他疾病发生,如心脑血管疾病、糖尿病等。对于恶性肿瘤患者的家庭来说,家属同样承受着巨大的心理压力,生活节律也会被改变,全科医生要善于发现家属的心理问题,给予心理支持和帮助。家庭成员中,有的具有血缘或遗传上的共同特征。社区的人群中,有的具有共同的生活方式、环境条件,也都应该注意对此类恶性肿瘤的预防等。

【问题 6】社区全科医生如何对恶性肿瘤患者开展康复治疗？

思路：该患者从医院回家后，社区全科医生对患者饮食、精神、心理、运动、睡眠等生活方式进行全方位的指导，并嘱其家庭成员（丈夫及子女）给予患者更多的关心和照顾。社区中医也为患者提供一些中医保健知识的指导和口服中药的调理方案，患者进入了全方位的康复阶段。

知识点

恶性肿瘤的三级预防

恶性肿瘤的三级预防也称康复预防，主要通过临床治疗、定期复查随诊、防治转移、监测新的病灶，并对晚期肿瘤患者进行止痛、康复或姑息治疗，以减轻患者痛苦、提高生活质量和延长生命。具体如下。

1. 恶性肿瘤的姑息治疗（palliative care）　又称“缓和治疗”。广义的姑息治疗也称为支持治疗（supportive care），狭义的姑息治疗主要针对难以根治的晚期癌症患者。安宁疗护，又称“临终关怀”或“宁养服务”，是为生命终末期的癌症患者、居丧期家属及照顾者提供医疗服务。恶性肿瘤的晚期患者多居住在家，非常需要全科医生为患者及家属提供全面的支持和帮助。

2. 癌症疼痛治疗

（1）病因治疗：针对引起癌痛的病因（癌症本身和并发症）进行治疗，如手术、放射治疗或化学治疗等。

（2）药物止痛治疗：总体原则：①口服给药：口服给药简单方便，为癌痛治疗的首选给药途径。②按阶梯给药：应根据患者的疼痛程度，有针对性地选用不同强度的镇痛药物。③按时用药：如重度疼痛患者，应以缓释阿片类药物作为基础维持用药，按规定时间间隔规律性给予止痛药。④个体化给药：是按照患者病情和癌痛缓解程度制订个体化用药方案。⑤加强监护：对使用止痛药的患者，要密切观察其疼痛缓解程度和机体反应情况。

按阶梯给药方法：WHO 三阶梯止痛原则：①轻度：选用非甾体抗炎药。②中度：选用弱阿片类药物。③重度：选用强阿片类药物，并可合用非甾体抗炎药及辅助药物。

（3）非药物止痛治疗：包括介入治疗、针灸和经皮穴位电刺激等物理治疗、认知-行为训练和社会心理支持治疗等。

3. 肿瘤康复治疗

（1）肿瘤营养疗法（cancer nutrition therapy，CNT）：理想的肿瘤营养治疗应该实现 4 个达标：满足 90% 液体目标需求、70%~90% 能量目标需求、100% 蛋白质目标需求及 100% 微量营养素目标需求。能量摄入推荐量为：卧床患者 20~25kcal/（kg·d），活动患者 25~30kcal/（kg·d）。蛋白质推荐范围为 1.2~2.0g/（kg·d）。恶病质患者蛋白质的总摄入量应该达到 1.8~2.0g/（kg·d）。

（2）运动疗法：应根据患者全身情况安排。体质较弱的卧床患者，可在床上做呼吸操、肢体躯干活动，以防止静脉血栓形成、坠积性肺炎等并发症。能下床活动的患者，应多安排户外运动，如散步、打太极拳、慢跑、做健身操等。

（3）生活能力与职业康复：全科医生帮助患者进行日常生活活动能力训练，以提高其生活自理能力，并协助其恢复原有工作或找到其他合适的岗位。

4. 全程生活方式管理　处于康复期、一般情况良好的肿瘤患者饮食上不宜忌口，但要戒烟、戒酒，可进行日常户外运动，包括散步、打太极拳等，但不宜进行剧烈的体育运动。根据身体恢复情况可考虑合适的工作，也可以有适度的性生活，以身体不疲劳为宜。

（王荣英）

思考题

1. 肿瘤的定义是什么？肿瘤是如何分类的？
2. 恶性肿瘤的危险因素有哪些？
3. 肿瘤的临床表现是什么？
4. 全科医生如何与专科医生联合管理肿瘤患者？
5. 全科医生如何对恶性肿瘤患者进行心理社会干预？


思考题解题思路


本章目标测试


本章思维导图